



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : منال سعيد محمود ابراهيم

العنوان : مم

الحي / المدينة : البدرشين

المحافظة : الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 19-09-2026

رقم البطاقة : 27803122100445 رقم التليفون : 01113855778

العمر (تاريخ الميلاد) : 12-03-1978 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي زولاديكس تحت الجلد لمدة 6 شهور

قسم العلاج :
الاورام

[14163]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / أ.د. / أ.د. / د. / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: منال سعيد محمود ابراهيم National ID: 27803122100445	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

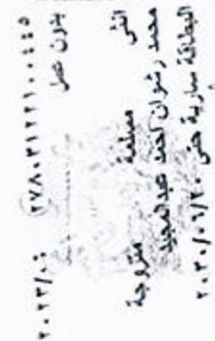
نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Goserelin (Zoladex) subcutaneous

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



مكتبة جامعة القاهرة
مكتبة جامعة القاهرة

مركز الصف - الجيزة
عزبة السلام
صعيد محمود إبراهيم
منال

03300122100660

K82024953

۲۵۱

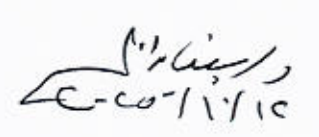
MDT FORM

14 / 10 / 2025 G

Name	داليا محمد محمد	MRN	2245/2025
Age	47 yr.	ID	CYN.YICCI-220
Menopausal status	Pre menopause	Phone	01148376597
NRS SCORE		Marital status	M
BMI		Family history	-ve
CO morbidity	M → Jcr S → Cxctb. ready by	REASON OF MDT	Post-op

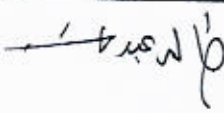
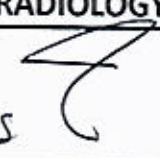
Clinical Data

BX: SIP up front Rt stomach MRN.			
ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
Sonomammography: Invasive duct carcinoma G2.			
Mets Workup: Fem nodules. Axillary L.N. 9/14 +ve			
 TNM Stage ypT2, yN2a			

Recommendations:	for Adj tht
	

MDT OUTCOME & PLAN	for Adjuvant chx 4x AC 4x TXT ② - PORT ③ - AI + zoledox x 5 yrs
--------------------	---

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
	Dr. Hoss 14/10/2025				

Patient Name : الأستاذ / منال سعيد محمود إبراهيم
Patient No. : 27803122100445
Path No. : 2965/25
Sex : Female
Age : 47 Y
Referring Doc :

Request No. : 13002616
Request Date : 29/09/2025
Verification Date : 07/10/2025
Financial Category : جوستاف روسي - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer, Up-Front.
Nature Specimen: Right mastectomy & axillary lymph nodes biopsy.

Gross Examination:

* Right mastectomy specimen measured 22x16x4 cm, with covering skin measured 18x12 cm. Nipple & Areola looked unremarkable grossly.

* Serialling showed a mass 4.5x2.5x2 cm, located 2 cm from the deep margin.

* Lymph nodes: Fibrofatty tissue piece measured 5x4x2cm, entangling 14 lymph nodes (Only five were submitted for frozen), the largest was 1.5x1x1 cm.

14 Blocks:

1:6- Mass., 7:10- Surrounding breast., 11- Deep margin., 12- SLNs., 13- Paraffin L.Ns., 14- Nipple & areola.

- Gross was done by; Dr. Mennan Hossam.

* Frozen Results:

- Positive metastatic deposits in five lymph nodes with extra-nodal extension (14 lymph nodes were detected, but only five were submitted for frozen).

Microscopic Examination:

* Histological Type: Invasive duct carcinoma.

* Grade 2 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).

* 50% Intermediate grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform pattern with comedo type necrosis).

* Angioinvasion: Present.

* Perineural invasion: Absent.

* Microcalcification: Present.

* Nipple & areola: Free.

* Deep margin: Free.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 12/10/2025 13:45:06

Page 1 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذ / منال سعيد محمود ابراهيم
Patient No. : 27803122100445
Path No. : 2965/25
Sex : Female
Age : 47 Y
Referring Doc :

Request No. : 13002616
Request Date : 29/09/2025
Verification Date : 07/10/2025
Financial Category : نفقة الدولة - جوستاف روسي
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

* Lymph nodes: Positive metastatic deposits in nine out of fourteen lymph nodes (9/14) with extra-nodal extension.

Diagnosis:

Right breast cancer (Up-front), Right mastectomy with axillary lymph nodes biopsy:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.
- 50% Intermediate grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform pattern with comedo type necrosis).
- Deep margin: Free.
- Nipple & areola: Free.
- Axillary lymph nodes: Positive metastatic deposits in nine out of fourteen lymph nodes (9/14) with extra-nodal extension.
- Stage: pT2, pN2a.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.

Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 12/10/2025 13:45:06

Page 2 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: منال سعيد محمود ابراهيم

Request type: مبادره

Hospital no:

Department: صحة مرارة

Referred by د/مروه حسن

Nature of specimen: tru cut biopsy

Age: 47years

Sex: female

Sub request type:

Pathology No.: 316B-2025

Date of Result: 2/8/2025

Receiving date: 22/7/2025

I.D. Number: 27803122100445

Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology :

multiple gray white tissue cores, totally submitted

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against:

ER- PR- Her2- KI67

Microscopic picture:

Section examined revealed breast core tissue showed clusters, nest, cords and cribriform pattern of anaplastic ductal cells with moderate anaplasia and moderate tendency to form tubules dispersed among desmoplastic stroma with mild lymphocytic response and focal necrosis. There is positive perineural infiltration but no evident peritumoral lymphovascular emboli. Also seen ductal carcinoma insitu comedo and solid sub type. The surrounding mammary tissue showed adenosis, duct ectasia with papillomatosis and focal calcification.

Immunohistochemical Result

ER: Positive Strong nuclear staining in 50% of tumor cells (Allred Score 7/8).

PR: Weak nuclear staining of 15% of tumor cells (Allred Score 4/8) Negative.

Her2: No membranous of tumor cells (Score 0) Negative

Ki67: Positive nuclear staining of 15% of tumor cells

Diagnosis: Right breast Mass: Tru Cut Biopsy:

Invasive Duct Carcinoma (NST), Grade II

Signature:

Dr.Nermine Nabil.M.D

Dr.Mona.Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

Nermine Nabil, M.D

Patient Name: Manal Saeed Mahmoud	Date : 18/08/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 47 Year(s)
Medical ID: 2245/2025	Pat. ID: 110990

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS: -

**** A reported case of breast cancer (IDC),**

Findings: I Chest:-

- Right breast spiculated mass measuring 1.6 x3.4 cm & overlying skin thickening
- Few enlarged right axillary L. Ns , the largest measures 12 x 10 mm.
- Few enlarged mediastinal L. Ns , the largest at prevascular group measures 9 x 3mm , likely reactive.
- Right upper lobe calcified pulmonary nodules 2-3 mm likely post granulomatous infection.
- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is mildly enlarged in size with homogenous CT texture. No enhancing focal lesions.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and right suprarenal.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- **L2 lucent lesion .**

Opinion:

- Reported case of breast cancer with axillary lymphadenopathy.
- L2 lucent lesion for correlation with bone scan.
- No hepatic & pulmonary metastatic deposits.

Dr. Reham Kheir,,,MD

Date : 08-09-2025 11:15

Medical No. : 197071

Name : Manal Said Mahmoud Ibrahim
Branch : Dokki
Ref. Physician Prof : Gostaf Roseh Hospital

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History:

- 46-year-old lady, with history of right breast cancer, referred for metastatic workup.

Technique:

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings:

- No abnormal active or cold focal bony lesions that may account for metastatic bone disease could be seen all over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are seen at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine